

TEMA 3.13 • OBSTETRICIA

Aborto Séptico

PERFIL EUNACOM 2.01.2.017
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Aborto Séptico

Contexto

Aborto complicado con infección — frecuentemente asociado a **aborto provocado clandestino** (sin medidas de asepsia).

Clínica

TABLA 3.13.1: SÍNTOMA VS FRECUENCIA	
SÍNTOMA	FRECUENCIA
Dolor + metrorragia	Más frecuentes
Fiebre	Presente siempre
Leucorrea por OCE	A veces (puede estar enmascarada por el sangrado)

Puede evolucionar a **sepsis** → **shock séptico** (o shock tóxico según microorganismo).

Diagnóstico

- **Clínico** (dolor + metrorragia + fiebre)
- **βHCG** → confirmar embarazo
- **ETV** → confirmar que es intrauterino + descartar absceso o mionecrosis
- **Exámenes de infección:** hemograma, PCR, VHS, hemocultivos
- Descartar otras causas de fiebre (infección urinaria, etc.)

Tratamiento: 3 pilares

1. Soporte

- Hidratación (suero fisiológico EV) - Si shock séptico/tóxico → **drogas vasoactivas**

2. Antibióticos (amplio espectro — infección polimicrobiana)

Esquema de elección: **Ampicilina + Gentamicina + Metronidazol** (cubre gram(+), gram(–) y anaerobios)

3. Evacuación del útero

- **Aspiración uterina** (AMEU o eléctrica) — **no legrado** - Timing: **idealmente tras 6 horas de antibióticos** (evidencia actual: no esperar días, evacuar pronto bajo cobertura ATB)

Complicaciones → Histerectomía

- Si no responde al tratamiento o presenta:
 - Mionecrosis
 - Absceso uterino
 - Metrorragia exsanguinante
 - Deterioro persistente
- **Laparotomía + histerectomía** (retirar el foco infeccioso)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Respecto a Aborto Séptico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Aborto Séptico. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Contexto
- Clínica
- Diagnóstico
- Tratamiento: 3 pilares
- 1. Soporte
- 2. Antibióticos (amplio espectro — infección polimicrobiana)
- 3. Evacuación del útero

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ABORTO SÉPTICO)

PREGUNTA 1

Respecto a Aborto Séptico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A) El diagnóstico de Aborto Séptico se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B) El manejo inicial de Aborto Séptico debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C) Todo paciente con Aborto Séptico requiere hospitalización inmediata
- D) El tratamiento de Aborto Séptico es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E) El seguimiento de Aborto Séptico no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Aborto Séptico?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Aborto Séptico. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: ABORTO SÉPTICO

Aborto complicado con infección — frecuentemente asociado a aborto provocado clandestino (sin medidas de asepsia).